CAIRN.INFO
CHERCHER, REPÉRER, AVANCER

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES PUBLIQUES DE LUTTE CONTRE LA CONSOMMATION NOCIVE D'ALCOOL EN FRANCE

Miléna Spach

S.F.S.P. | « Santé Publique »

2016/4 Vol. 28 | pages 461 à 470

ISSN 0995-3914

Article disponible en ligne à l'adresse :

http://www.cairn.info/revue-sante-publique-2016-4-page-461.htm

Pour citer cet article :

Miléna Spach, « Enjeux économiques et politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool en France », *Santé Publique* 2016/4 (Vol. 28), p. 461-470.

Distribution électronique Cairn.info pour S.F.S.P..
© S.F.S.P.. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Enjeux économiques et politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool en France

Economic issues and public alcohol abuse prevention policies in France

Miléna Spach[1]

Résumé

Objectif : Analyser le poids du marché alcoolier sur la mise en place de politiques publiques volontaristes, au travers d'une revue de la littérature critique des politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool.

Méthode : Une recherche documentaire et une analyse des données économique du marché alcoolier en France ont été réalisées. Le panorama des politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool a été élaboré d'un point de vue historique, en distinguant les politiques de lutte contre l'ivresse, de protection des populations vulnérables, de lutte contre l'alcoolémie au volant ou encore en milieu professionnel.

Résultats : Les politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool visent principalement à diminuer les conséquences nocives de l'alcool survenant à l'issue d'un épisode de consommation (accident de la route, accidents de la voie publique, etc.), en négligeant les conséquences de long terme (cancer, cirrhose, etc.). De plus, tandis que la taxation figure parmi les outils de santé publique les plus efficaces pour diminuer le coût que l'alcool fait supporter à la société, l'État exerce une protection législative et fiscale sur les boissons alcooliques françaises. En particulier, le vin bénéficie d'une taxation inférieure aux autres alcools dont le titre alcoométrique volumique est supérieur (eaux-de-vie, liqueurs, etc.). Une explication quant à l'orientation des politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool réside dans le poids économique de l'alcool.

Conclusion : Au regard de la mortalité engendrée par l'abus d'alcool, l'engagement de la France dans une politique publique volontariste est nécessaire. Dans ce sens, une politique de taxation de l'alcool selon la quantité d'alcool contenue, l'instauration d'un prix-plancher du gramme d'alcool ou encore l'augmentation des taxes sur l'alcool sont autant de politiques à considérer en vue d'infléchir la mortalité liée à l'alcool.

Mots-clés : Consommation d'alcool ; Fiscalité ; Politique publique ; Politique de santé ; Mortalité ; Taxes.

Summary

Objective: *To analyse the impact of the alcohol market on the implementation of strong-willed public alcohol abuse prevention policies based on a critical review of the literature.*

Method: *Documentary research and analysis of the alcohol market economic data were performed. An overview of public alcohol abuse prevention policies was conducted from a historical perspective by distinguishing drunkenness control policies, protection of vulnerable populations, and the fight against drink driving and drinking in the workplace.*

Results: *Public alcohol abuse prevention policies are primarily designed to reduce the harmful consequences of alcohol occurring as a result of a drinking episode (motor vehicle accident, highway accidents, etc.), while neglecting the long-term consequences (cancer, cirrhosis, etc.). Moreover, while taxation is one of the major public health tools used to reduce the costs of alcohol-related damage on society, the State exercises legislative and tax protection for alcoholic beverages produced in France. In particular, wine benefits from a lower tax rate than other stronger forms of alcohol (spirits, liquors, etc.). The economic weight of the alcohol market can provide an explanation for these public alcohol abuse prevention policies.*

Conclusion: *In view of the mortality caused by alcohol abuse, France must implement a proactive public policy. An alcohol taxation policy based on the alcohol content, a minimum unit pricing for alcohol, or higher taxes on alcohol are public policies that could be considered in order to reduce alcohol-related mortality.*

Keywords: *Alcohol drinking; Health policy; Mortality; Public policy; Taxation; Taxes.*

[1] Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Maison des sciences économiques – 106-112 Boulevard de l'hôpital – 75013 Paris – France.

Correspondance : M. Spach
milena.spach@gmail.com

Réception : 17/09/2015 – *Acceptation :* 27/06/2016

Introduction

La France est un pays traditionnellement consommateur et producteur d'alcool. D'après l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les français âgés de 15 ans et plus ont consommé 12 litres d'alcool pur en 2014, dont 7 litres de vins, 2,3 litres de bières et 2,5 litres de spiritueux. Si 4,6 millions de français consomment quotidiennement de l'alcool en 2014 [1], la consommation d'alcool n'est toutefois pas uniformément répartie dans la population. La consommation d'alcool des 20 % de la population qui boit le plus, représente 50 % de tout l'alcool consommé en 2012 [2]. Par ailleurs, en 2014, les ménages français ont dépensé 20,6 milliards d'euros dans l'achat de boissons alcooliques ; cette dépense représente 1,4 % de la consommation des ménages [3]. Enfin, en 2011, le chiffre d'affaires des boissons alcooliques s'élève à 22,1 milliards d'euros, dont 11,4 milliards sont réalisés à l'export [4].

Si l'alcool fait partie intégrante de la culture française [5, 6], en termes de risque de décès l'alcool figure néanmoins devant la cocaïne et l'héroïne [7]. L'alcool représente la seconde cause de mortalité évitable en France – après le tabac –, avec une estimation de 49 000 décès qui lui seraient attribuables en 2009 [8]. De plus, bien que la consommation d'alcool globale régresse en France, en 2014, 31 % des 18-75 ans sont des buveurs à risque ponctuel et 8 % à risque chronique[1] [1]. Or, les buveurs à risque, au-delà des dommages qu'ils s'infligent à eux-mêmes, sont source d'externalités négatives pour la société. En 2010, le coût social de l'alcool en France est estimé à 120 milliards d'euros[2] [9]. Afin de limiter le coût que la consommation d'alcool fait peser sur la société, des politiques publiques sont mises en place. Ces politiques se matérialisent par des restrictions et des encadrements de consommation, des limitations de l'âge minimum légal de consommation ou encore des politiques d'information sur les risques. Toutefois, des politiques visant à augmenter ou à modifier la structure des taxes sur l'alcool peinent à être mises en place en France.

L'objectif de cet article est d'analyser en quoi le poids économique de l'alcool constitue (ou non) un frein à la mise en place de politiques publiques volontaristes. Plus précisément, nous montrons que le poids économique que représente le marché alcoolier conduit à orienter les politiques publiques vers une lutte contre les risques de court terme (accidents de la route, etc.), aux dépens des risques de long terme (cancers, cirrhose, etc.) et ce dans une volonté de protection des productions françaises tel que le vin. Enfin, nous soulignons que différentes politiques publiques volontaristes sont envisageables : taxation des boissons alcooliques selon la quantité d'alcool contenue, prix-plancher du gramme d'alcool pur, hausse des taxes sur les boissons alcooliques.

La structure de l'article est la suivante. Nous présentons tout d'abord la méthode sur laquelle s'est appuyé l'article, puis les risques liés à l'abus d'alcool avant de retracer l'histoire des politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool. Ensuite, nous analysons le poids économique de l'alcool et discutons de l'intérêt de différentes politiques publiques dans la lutte contre l'abus d'alcool. La dernière section conclut l'article.

Méthodes

Afin d'analyser les enjeux économiques ainsi que les politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool en France, nous avons choisi de combiner deux approches complémentaires : d'une part, une recherche documentaire approfondie sur les politiques de lutte contre l'abus d'alcool ; d'autre part, une analyse des données économiques du marché alcoolier en France.

La recherche documentaire a été menée par les principaux moteurs de recherche sur Internet, mais également au moyen de sites Internet juridiques (*via* www.legifrance.gouv.fr) et politiques (notamment par les sites internet de l'Assemblée nationale (www.assemblee-nationale.fr) et du Sénat (www.senat.fr)). Les requêtes ont été formulées sur ces différentes bases en utilisant principalement les mots-clés suivants : Loi alcool – Loi Évin – Fiscalité alcool – Économie alcool. La période de recherche n'a pas été limitée dans le temps. Tous les types de documents – textes de loi, articles, revues de la littérature, thèses, rapports – ont été retenus. Ensuite, les données économiques ont été obtenues au travers des sites Internet et des rapports de l'Insee, de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), de l'Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT) et de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

[1] Le test Audit-C (*Alcohol use disorder identification test*) distingue quatre niveaux de buveurs : les buveurs « sans risque occasionnel », « sans risque régulier », « à risque ponctuel » (qui boivent moins que les recommandations courantes mais boivent parfois six verres ou plus) et « à risque chronique » (qui boivent plus que les recommandations courantes ou, au moins une fois par semaine, six verres ou plus).

[2] D'après Kopp, « le coût social est composé du coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de production) et du coût pour les finances publiques (dépenses de prévention, répression et soins, économie de retraites non versées, et recettes des taxes prélevées) » [9].

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Résultats

Les risques associés à la consommation d'alcool

Les risques associés à la consommation d'alcool se décomposent en risques de court terme (consommation importante d'alcool à un moment donné) et en risques de long terme (consommation nocive d'alcool sur une période longue).

Les risques de court terme

Le risque de court terme le plus manifeste concerne les accidents de la route : l'alcool multiplie par 8,5 le risque d'être responsable d'un accident mortel [10]. De plus, en raison de son effet désinhibiteur et de la perte de contrôle qu'il engendre, l'alcool est à l'origine de violence contre soi (suicide, etc.) ou contre autrui (agression sexuelle, etc.). L'abus d'alcool cause aussi des risques pour soi et autrui, par exemple par la transmission de maladies infectieuses à l'issue de relations sexuelles non protégées. Enfin, l'effet psychoactif de l'alcool modifie la perception de l'environnement qu'a un individu, entraînant chutes, accidents de la voie publique, etc. En France, sur les 49 000 décès estimés comme étant imputables à la consommation d'alcool en 2009, 8 000 décès relèvent de ces causes (accident de la route, violence, etc.) [8]. À cette mortalité s'ajoutent les hospitalisations provoquées par les intoxications éthyliques aiguës. En 2011, 100 404 passages aux urgences pour intoxication éthylique aiguë ont été dénombrés, soit 1 % de l'ensemble des passages aux urgences [11]. Enfin, en milieu professionnel, l'alcool est à l'origine de 10 à 20 % des accidents du travail [12], mais aussi d'absentéisme [13] et de pertes de production pour l'entreprise [14]. Pour l'année 2010, Kopp estime que l'alcool inflige des pertes de production à la société s'élevant à 9 milliards d'euros [9].

Les risques de long terme

En 1848, Huss définit l'alcoolisme chronique comme « *un processus d'empoisonnement chronique* » (cité dans [15]). Le risque de cancer imputable à la consommation d'alcool est évoqué pour la première fois en 1910 [16] ; association qui a, par la suite, été confirmée par différentes études épidémiologiques [17]. En effet, « *au-delà des phénomènes de dépendance et d'ivresse, une consommation inscrite dans les habitudes de vie peut être excessive et avoir des conséquences à long terme sur la santé* » [18]. Actuellement, la majorité des études s'accorde à dire qu'une consommation d'alcool journalière comprise entre 0 et 20 grammes d'alcool pur – soit inférieure à deux verres standards[3] – induit une diminution de la mortalité due à certaines pathologies cardiovasculaires [10]. Par contre, entre 20 et 50 grammes d'alcool pur par jour les risques cardiovasculaires et de cirrhose sont accrus [10]. L'effet bénéfique d'une consommation modérée d'alcool fait néanmoins l'objet de controverses. Dès 13 grammes d'alcool pur par jour, la consommation d'alcool serait nocive et cause de mortalité [8]. En France, sur les 49 000 décès estimés comme étant attribuables à l'alcool en 2009, 15 200 décès relèveraient de cancers (foie, bouche, pharynx, etc.), 12 233 de maladies du système circulatoire (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique, etc.), 7 772 de maladies du système digestif (pancréatites, cirrhoses, etc.) et 4 075 proviendraient d'autres causes médicales (diabète, épilepsie, etc.) [8].

Histoire des politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool

Si, en termes de décès, les risques de long terme excèdent les risques de court terme, les politiques de lutte contre l'abus d'alcool se sont toutefois majoritairement attachées à lutter contre les risques de court terme (répression de l'ivresse, prévention routière, etc.), en négligeant en partie les risques de long terme. Toutefois, puisque les adolescents sujets aux alcoolisations ponctuelles importantes sont plus susceptibles, une fois adultes, de présenter une dépendance à l'alcool [22], la lutte contre les risques de court terme permet d'agir, en partie, en prévention des risques de long terme.

Les politiques publiques de lutte contre l'ivresse et l'alcoolisme en population générale

Dans la société française, l'ivresse est réprimée pour la première fois par le premier capitulaire de Charlemagne en 802 : les individus s'adonnant à l'ivresse sont soumis à des châtiments corporels et assujettis à boire de l'eau [19]. Puis, l'édit du 30 août 1536 de François Ier punit les individus en état d'ébriété au moyen d'amputation d'oreille et, en cas de récidive, d'un bannissement [20]. Devant la manne financière que représente l'alcool, Colbert, par les ordonnances

[3] En France, un verre standard d'alcool contient 10 grammes d'alcool pur, soit un demi de bière à 5° (25 cl), une coupe de champagne à 12° (10 cl), un verre de vin à 12° (10 cl), un verre d'apéritif à 18° (7 cl) ou encore un verre de whisky à 40° (3 cl).

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

sur les aides, instaure une taxe sur l'alcool en 1680. Ensuite, la loi du 23 janvier 1873, dite loi Théophile Roussel, condamne à des amendes les individus trouvés en état d'ivresse dans un lieu public, et à des peines d'emprisonnement en cas de récidive. Toutefois, la consommation d'alcool s'accroît. Les français buvaient annuellement un litre d'alcool pur par habitant en 1830 contre vingt litres en 1910 [5]. Cette hausse s'explique en partie par l'absence de réglementation des débits de boissons, dont on dénombre 475 000 débits de boissons en 1900 [5]. Enfin, le vin, le cidre, le poiré, la bière et l'hydromel ne sont, au début du XXe siècle, pas assimilés à de l'alcool mais à des boissons saines, contrairement aux boissons industrielles – c'est-à-dire les boissons distillées – néfastes pour la santé [21].

Au-delà de la répression de l'ivresse, différentes mesures de lutte contre l'alcoolisme se développent au cours de la Première Guerre mondiale : interdiction de vente d'alcool aux militaires, interdiction de l'absinthe, augmentation des droits sur les spiritueux, abolition du privilège des bouilleurs de cru[4]. Sous la pression de l'industrie alcoolière, les mesures entreprises sous la Première Guerre mondiale sont abolies pendant l'entre-deux-guerres. Plus encore, des lois viennent favoriser l'ouverture des débits de boissons et un comité de propagande en faveur du vin, placé sous la tutelle du ministre de l'Agriculture, est instauré en 1931 [19]. Sous le régime de Vichy, des mesures de lutte contre l'alcoolisme sont engagées (limitation du nombre de débits, encadrement et limitation des ventes d'alcool, etc.), mesures qui seront supprimées lors de la Libération. Le gouvernement Mendès France, avec la loi du 15 avril 1954, loi sur le traitement des alcooliques dangereux pour autrui, entend lutter contre l'alcoolisme par des politiques de prévention, d'information et des mesures de traitement des alcooliques dangereux – alors considérés comme des malades. Enfin, l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959 instaure le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, offrant la première classification des boissons[5] et des débits de boissons.

Les ordonnances du 29 novembre 1960 énoncent que l'objectif que doit poursuivre l'État réside dans la modération des usages, seule la consommation excessive d'alcool est considérée comme nocive. Ces ordonnances pointent également le caractère aberrant d'un régime de prohibition pour la France, de par les intérêts économiques et les traditions. Le caractère héréditaire du privilège des bouilleurs de cru est définitivement aboli en 1960. La publicité pour les boissons alcooliques du cinquième groupe est interdite, de même que la publicité dans les enceintes sportives. Mais, en 1980, la Commission des communautés européennes condamne la République Française pour réglementation discriminatoire de la publicité des boissons alcooliques. La Commission fait valoir que le régime de publicité a été mis en place de façon à prohiber ou à limiter la publicité pour les produits alcooliques importés et à favoriser la publicité pour les produits nationaux concurrents. Si la publicité pour l'alcool est interdite sur les chaînes télévisées publiques, la libéralisation des ondes en 1981 voit naître des chaînes privées non soumises à la même règlementation. Ainsi, en 1984, la Cinq obtient une autorisation de diffuser des publicités en faveur des alcools à moins de neuf degrés. Cette autorisation s'étend peu à peu à TV6, Canal + et TF1 [23]. Mais, la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, dite loi Barzach, interdit la publicité pour toute boisson alcoolique de plus de un degré sur les chaînes de télévision publiques et privées.

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Évin, vise à dissuader « *les consommations excessives ou inadaptées* ». La loi Évin interdit la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques, exception faite pour la publicité dans la presse écrite, par radiodiffusion, etc. Lorsque la publicité pour l'alcool est autorisée, elle doit s'accompagner du message : « *L'abus d'alcool est dangereux pour la santé* ». Cette loi entend aussi lutter contre la consommation d'alcool dans les enceintes sportives, interdisant les buvettes et la publicité dans les stades, piscines et terrains de sport.

La loi Évin a ensuite été prolongée par différentes mesures réglementaires. Avec la loi du 6 décembre 1993, l'ivresse dans les enceintes sportives devient un délit pouvant être puni de peine de prison, notamment en cas de violences. La délibération n° 2008-51 du 17 juin 2008 renforce l'interdiction de publicité en faveur des boissons alcooliques. Mais, ne sont pas constitutifs d'une publicité indirecte ni d'une propagande « *les reportages évoquant directement ou indirectement la production d'alcool, notamment le vin, dans la mesure où l'œnologie et la viticulture relèvent du patrimoine national ou encore l'information sur des événements saisonniers à forte notoriété tels que la mise en vente du "Beaujolais nouveau"* ».

Toutefois, sous le poids de l'industrie alcoolière, la loi Évin est progressivement affaiblie. Si le décret du 26 août 1992 prévoit une dérogation annuelle de la vente d'alcool dans les enceintes sportives, le décret du 8 août 1996, dit

[4] Le privilège des bouilleurs de cru consiste à exonérer de taxe les milles premiers degrés d'alcool pur produits par les bouilleurs ambulants.

[5] 1er groupe. – Les boissons sans alcool. 2e groupe. – Les boissons fermentées non distillées (vin, bière, cidre, poiré, hydromel). 3e groupe. – Les apéritifs à base de vin (de type Martini) et les vins de liqueur (Porto). 4e groupe. – Les eaux-de-vie (cognac, rhum, etc.) et les liqueurs. 5e groupe. – Les apéritifs à base d'alcool (pastis) ou à base de céréales (whisky, gin, etc.).

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

« *amendement buvette* », porte ce nombre à dix. De plus, le projet de la loi d'orientation agricole du 17 octobre 2005 prévoit la création d'un conseil de modération et de prévention sur les risques liés à l'alcool, conseil devant être consulté lors de projets de campagne de communication publique sur la consommation de boissons alcooliques. En réaction, Martin – député de la Marne – déclare que la création de ce conseil permettra de « *modérer les campagnes de prévention parfois discriminatoires envers les producteurs de vins et de champagne* » (cité dans [24]). Ensuite, la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST), autorise la publicité pour l'alcool sur internet, à l'exception des sites destinés à la jeunesse, au sport et à l'activité physique. Enfin, le 15 septembre 2015, est adopté un amendement à la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Proposé par Courteau – sénateur de l'Aude – cet amendement redéfinit les contours de la loi Évin. En différenciant information et publicité, cet amendement assouplit l'évocation de l'alcool dans l'information médiatique et oenotouristique. Les contenus relatifs à une région de production ou une indication géographique liés à une boisson alcoolique ne sont alors plus considérés comme de la publicité. En réaction, plusieurs addictologues et associations de santé sont venus dénoncer les conséquences sanitaires de cet amendement, à l'image de Fédération Addiction, énonçant que « *L'histoire retiendra que la régulation qu'avait préservée une loi de santé a été détruite par une loi économique dite "de croissance et d'activité"* »[6].

Les politiques publiques visant à protéger les populations vulnérables

Différentes politiques publiques ont cherché à protéger les populations les plus vulnérables à l'alcool telles que les mineurs et les femmes enceintes. Concernant la protection des mineurs, la loi Théophile Roussel de 1873 dispose que les débitants d'alcool ayant servi de l'alcool à des mineurs encourent une amende et jusqu'à l'emprisonnement si le mineur est ivre. Puis, la circulaire du 8 août 1956 restreint la consommation de boissons alcooliques dans les cantines et internats scolaires. La volonté de protéger les plus jeunes s'affirme par l'ordonnance de 1959 qui interdit aux mineurs de moins de 20 ans la consommation de boissons distillées dans les débits de boissons, la vente à emporter étant autorisée dès 16 ans. Toutefois, la vente de boissons fermentées (vin, cidre, poiré, bière, hydromel) est permise pour les mineurs de 12 ans et plus. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, instaure une taxation sur les boissons alcooliques aromatisées, aussi appelés prémix[7]. Ensuite, la loi HPST interdit la vente et l'offre gratuite d'alcool aux mineurs de moins de 18 ans. Cette loi marque aussi la fin des *open bar* – consommation d'alcool à volonté contre le paiement d'un forfait –, des opérations de distribution gratuite d'alcool et impose aux débits de boissons pratiquant des *happy hours* de proposer également des boissons non alcoolisées à prix réduits.

Pour les femmes enceintes, les politiques publiques de lutte contre les méfaits de l'alcool visent à protéger le fœtus. La consommation d'alcool au cours de la grossesse peut provoquer un syndrome d'alcoolisation fœtale se traduisant, chez l'enfant, par un retard de croissance, des anomalies du système nerveux central ou encore des anomalies cranofaciales. Le 2 octobre 2006, en dépit d'une forte opposition parlementaire [5], est adopté un arrêté imposant l'inscription d'un message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool pour les femmes enceintes sur les étiquettes des boissons alcooliques.

La lutte contre les méfaits de l'alcool en milieu professionnel

La prévention des conduites addictives en milieu professionnel devient un enjeu de santé publique dès les années 1960. L'article R.4228-20 du Code du travail dispose qu' « *il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans l'entreprise des personnes en état d'ivresse* » et qu'aucune boisson alcoolique n'est autorisée sur les lieux de travail, exception faite des boissons fermentées. Les articles R.4228-19 et R.422562 du Code du travail prévoient également la mise à disposition d'eau potable et fraîche par l'employeur. La circulaire du 13 janvier 1969 apporte des recommandations pour l'application de ces textes et précise que c'est au règlement intérieur de délimiter le cadre de consommation des boissons alcooliques dans l'entreprise (interdiction, limitation aux repas en dehors des horaires de travail, etc.). Enfin, le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 renforce l'encadrement de la consommation d'alcool en milieu professionnel et autorise les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation d'alcool, y compris pour les boissons fermentées.

[6] Lien : http://www.federationaddiction.fr/communique-presse-palme-de-linconsequence-la-loi-du-marche-casse-la-loi-evin/ (consulté le 3 février 2016).

[7] Les prémix se composent d'un mélange entre une boisson alcoolisée et une boisson non-alcoolisée (soda, etc.), de telle sorte que les effets de l'alcool soient présents mais que le goût de l'alcool soit masqué par le goût sucré. Leur titre alcoométrique volumique est compris entre 3 et 5 %.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Les politiques de lutte contre l'alcool au volant

Le délit spécifique de conduite en état d'ivresse, ou sous l'empire d'un état alcoolique, est reconnu pour la première fois sous De Gaulle. L'ordonnance n° 58-1216 du 15 décembre 1958 stipule que la conduite en état d'ivresse manifeste – sans que le taux légal d'alcoolémie soit fixé – est une infraction punie d'un an d'emprisonnement et de 500 000 (anciens) francs d'amende. Par la suite, la loi n° 65-373 du 18 mai 1965 réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique « *même en l'absence de signe manifeste d'ivresse* ». Cette loi autorise aussi le dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré en cas d'accident ou d'infraction grave au code de la route.

Entre 1970 et 2004, plusieurs lois s'attachent à définir un taux légal d'alcoolémie au volant. La loi n° 70-597 du 9 juillet 1970 instaure un taux légal d'alcoolémie à 0,8 gramme par litre (g/l) de sang. Entre 0,8 g/l et 1,2 g/l de sang, le conducteur risque une contravention, au-delà la conduite constitue un délit passible de deux ans d'emprisonnement. La loi n° 78-732 du 12 juillet 1978 instaure des contrôles d'alcoolémie même en l'absence d'infraction ou d'accident. Avec la loi n° 83-1045 du 8 décembre 1983, la peine d'emprisonnement est encourue dès 0,8 g/l de sang. La loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 institue le retrait immédiat du permis de conduire en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et ce pour une durée de 72 heures. Le décret n° 95-962 du 29 août 1995 abaisse à 0,5 g/l de sang le seuil d'alcoolémie légal. Enfin, le décret n° 2004-1138 du 25 octobre 2004 diminue le seuil d'alcoolémie légal pour les véhicules de transport en commun : une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,2 g/l devient punie par une amende de quatrième classe.

En 2009, la loi HPST limite la vente d'alcool dans les stations-services. La vente d'alcool à emporter y est interdite entre 18 heures et 8 heures et la vente d'alcool réfrigéré – alcool destiné à être consommé rapidement – devient interdite. En dehors des stations-services, les exploitants vendant de l'alcool réfrigéré doivent, pour pouvoir vendre ces boissons entre 22 heures et 8 heures, suivre une formation sur la prévention et la lutte contre l'alcoolisme. Enfin, la loi HPST renforce les pouvoirs des agents de contrôle et les compétences des mairies pour interdire la vente d'alcool à emporter entre 20 heures et 8 heures.

Au début des années 2010, deux axes de prévention routière se développent : l'auto-dépistage d'alcoolémie et la prévention de la récidive de conduite en état d'alcoolémie. La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, loi d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure (dite loi LOPPSI) dispose que « *dans les débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre 2 heures et 7 heures, un ou plusieurs dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique doivent être mis à la disposition du public* ». Puis, le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 rend obligatoire la possession d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur. Les conducteurs de cyclomoteurs de plus de 50 cm^3 sont concernés par cette obligation à compter du 10 janvier 2013. Concernant la récidive, la loi LOPPSI permet d'obliger un conducteur ayant été sanctionné pour conduite sous l'influence de l'alcool à utiliser un éthylotest électronique avant de pouvoir démarrer son véhicule – dit éthylotest anti-démarrage (EAD).

Le poids économique de l'alcool en France

Les politiques publiques de lutte contre l'abus d'alcool visent donc davantage à réduire les risques de court terme que ceux de long terme. Cette volonté est revendiquée dans le livre blanc de la viticulture française, déclarant qu'« *il ne semble pas souhaitable de rester sur une approche globale semblant ciblée exclusivement sur la baisse de la consommation totale en France et il apparaît plus adapté de garder toutes les énergies mobilisées contre les surconsommations, les excès et les comportements délinquants* » [6]. Au-delà de la protection législative exercée sur les boissons fermentées, la France fait montre d'une volonté de protection fiscale des boissons alcooliques produites sur le sol français, au premier rang desquelles le vin.

Le poids économique de l'industrie alcoolière

En France, le chiffre d'affaires des boissons alcooliques s'élève à 28,1 milliards d'euros en 2011, le vin contribuant à hauteur de 59 %, les spiritueux 32 % et les bières 8 % [13]. Ce chiffre d'affaires comprend les dépenses des ménages (16,7 milliards) plus les exportations (11,4 milliards). Les exportations d'alcool en France figurent parmi les premiers contributeurs de la balance commerciale [25]. D'après la direction générale des douanes et des droits indirects, les importations françaises de boissons alcoolisées représentent 2,4 milliards d'euros en 2011, contre 11,4 milliards d'euros pour les exportations, dont 7,2 milliards pour les vins et 4 milliards pour les spiritueux [13]. De plus, d'après l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, avec 47,4 millions d'hectolitres produits en 2015, la France est le deuxième producteur mondial de vin, derrière l'Italie (48,9 milliards d'hectolitres).

En 2012, la filière vitivinicole représente, selon les syndicats professionnels et le ministère de l'Agriculture, plus de

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Tableau I : Fiscalité applicable aux boissons alcooliques au 1er janvier 2016

	Droit de circulation	Droit de consommation	Cotisation sécurité sociale	TVA
Vins, vins mousseux, cidres, poirés et hydromels	Vins tranquilles : 3,77 €/hl Vins mousseux : 9,33 €/hl Cidres/Poirés/Hydromels : 1,33 €/hl	Aucun	Aucune	19,6 %
Bières	Aucune	TAV ≤ 2,8% : 3,70 €/degré/hl TAV ≥ 2,8% : 7,41 €/degré/hl	TAV ≥ 18% : 2,96 €/degré/hl	19,6 %
Produits intermédiaires	Aucune	188,41 €/hl	TAV ≥ 18% : 47,11 €/hl	19,6 %
Alcools avec TAV > 22%	Aucune	1737,56 €/hlap	TAV ≥ 18% : 557,90 €/hlap	19,6 %

Source : Ministère des finances et des comptes publics.

550 000 emplois directs (viticulture, distribution et vente du vin) et indirects (tonnellerie, chaudronnerie, logistique, etc.). Pour la bière, l'Association des Brasseurs de France évalue, en 2015, le nombre d'emplois indirects à 64 000. La Fédération Française des Spiritueux compte quant à elle 100 000 emplois directs et indirects en 2014. Ainsi, l'industrie alcoolière, *via* la production, les exportations et les emplois qu'elle génère, représente un groupe de pression important. En particulier, la mobilisation du lobby alcoolier s'est avérée efficace pour affaiblir la loi Évin. De plus, la volonté de protéger les alcools produits en France, en particulier le vin, est illustrée par le livre blanc remis au Premier ministre par cinq députés et sénateurs issus de régions vitivinicoles affirmant que « *le vin n'est pas une drogue* » [6].

Le régime fiscal des boissons alcooliques

Le régime fiscal des boissons alcooliques[8] est hétérogène. D'une part, la législation fiscale distingue quatre catégories de boissons alcooliques : (i) les vins, vins mousseux, cidres, poirés et hydromels ; (ii) les bières ; (iii) les produits intermédiaires[9] et (iv) les alcools dont le titre alcoométrique volumique (TAV) excède 22 %. D'autre part, les boissons alcooliques sont soumises à quatre droits et taxes indirectes : (i) un droit de circulation (accise fixée par hectolitre (hl)) ; (ii) un droit de consommation (accise fixée par hectolitre d'alcool pur (hlap)) ; (iii) une cotisation pour le financement de la Sécurité sociale (accise fixée par hectolitre et qui ne s'applique qu'aux boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 18 %) et (iv) une taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le tableau I synthétise la fiscalité, applicable au 1er janvier 2016, selon les différentes catégories de boissons alcooliques.

Le niveau de taxation croît avec le titre alcoométrique volumique, exception faite pour les vins, cidres, poirés et hydromels qui sont moins taxés. D'après la commission des affaires sociales, le montant des droits indirects perçus sur l'alcool (hors TVA) s'élève à 3,3 milliards d'euros en 2013 et se répartit tel que les spiritueux génèrent 81 % des recettes fiscales, les bières 12 %, les vins, cidres, poirés et hydromels 4 % et les produits intermédiaires 3 %. Néanmoins, la contribution fiscale de chaque type de boisson alcoolique ne reflète pas la répartition de consommation en volume. En effet, d'après l'OMS, la consommation française d'alcool pur par habitant âgé de 15 ans ou plus en 2013 était de 6,9 litres de vin contre 2,5 litres de spiritueux et 1,7 litre de bière. Ainsi, le vin, consommé 2,8 fois plus, contribue vingt fois moins que les spiritueux aux recettes fiscales. Plus encore, d'après la commission des affaires sociales, la charge fiscale pour dix grammes d'alcool pur est de 0,37 centimes d'euros pour le vin tranquille, 0,92 centimes d'euros pour le vin pétillant, entre 1,83 et 3,66 centimes d'euros pour la bière et 22,9 centimes d'euros pour les spiritueux ; soit un rapport de 1 à 62 entre le vin tranquille et les spiritueux. Le régime fiscal dont bénéficie le vin illustre alors la volonté de protéger la production et la consommation de vin en France.

[8] « *Sont considérées comme boissons alcooliques, au sens de la réglementation communautaire relative aux accises, les boissons ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % (à l'exception des bières qui sont des boissons alcooliques dès lors que leur titre alcoométrique volumique acquis atteint ou dépasse 0,5 %)* ». Disponible sur : http://www.douane.gouv.fr/articles/a10958-definition-et-regime-fiscal-des-alcools-et-des-boissons-alcooliques (consulté le 17 mai 2015).

[9] Les produits intermédiaires sont les boissons dont le titre alcoométrique volumique est compris entre 1,2 % et 22 %, et qui ne sont ni des vins ni des bières.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Discussion

En France, les taxes sur les alcools sont actuellement décorrélées de l'inflation et sont spécifiques à chaque type d'alcool. D'après l'Insee, le prix relatif de l'alcool diminue depuis les années 1960. Indexer les taxes pesant sur l'alcool sur l'inflation permettrait pourtant de réduire la consommation d'alcool. En effet, Wagenaar, Salois et Komro [26], par une méta-analyse de 1 003 estimations provenant de 112 études, estiment que l'élasticité prix de la demande d'alcool se situe à – 0,51 ; autrement dit qu'une hausse de 10 % du prix de l'alcool réduirait de 5,1 % la demande d'alcool. De plus, Elder *et al.* [27], à l'issue d'une revue de la littérature de 38 études, concluent à une élasticité médiane de – 0,79 pour les spiritueux, de – 0,64 pour le vin et de – 0,5 pour la bière.

L'augmentation des taxes sur l'alcool est même considérée comme étant la politique la plus efficace dans la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool [28, 29]. Relever les taxes sur l'alcool permettrait de diminuer la mortalité liée aux accidents de voiture, le risque de mort par cirrhose du foie, par cancer du sein ou encore par suicide [27]. Wagenaar, Tobler et Komro [30], suite à une méta-analyse de cinquante études contenant 340 estimations, concluent que doubler les taxes sur l'alcool réduirait la mortalité liée à l'alcool de 35 %. En particulier, les accidents de voiture mortels diminueraient de 11 %, les maladies sexuellement transmissibles de 6 %, la violence de 2 % et le crime de 1,4 %. Pour les décès par cirrhose, une hausse de 10 % du prix des boissons alcooliques conduirait, à long terme, à une baisse de la mortalité de 8,3 à 12,8 % [31].

Aussi, dans la lutte contre les méfaits de l'alcool, deux interventions se révèlent plus efficaces et plus coût-efficace que les autres : la taxation et l'interdiction de publicité [28]. Et seule la taxation permet, avec une probabilité unitaire – soit dans 100 % des cas –, d'obtenir des bénéfices supérieurs aux coûts [28]. Par une analyse comparative coût-efficacité de différentes politiques visant à réduire le poids des consommations d'alcool dangereuses pour douze sous-régions de l'OMS, Chisholm *et al.* [32] montrent que la taxation est l'outil le plus efficace pour les populations ayant une prévalence de consommateurs excessifs supérieure ou égale à 5 %, tels que les pays européens et d'Amérique du Nord.

Il est également à noter qu'augmenter les taxes sur l'alcool peut permettre des recettes fiscales supplémentaires pour l'État, fonds pouvant par la suite être affectés à des programmes de prévention et de traitement des problèmes liés à l'alcool [27]. Pour les États-Unis, instaurer une taxe de vingt-cinq centimes par verre standard[10] sur les consommations d'alcool diminuerait de 9,2 % la consommation d'alcool et engendrerait 7,9 milliards de dollars supplémentaires pour l'État, dont 82,7 % seraient apportés par les buveurs excessifs (soit 6,5 milliards de dollars) [29]. Dans le cas de la France, accroître de 18 % le prix, toutes taxes comprises, des boissons alcooliques – soit une hausse de 78 % des accises sur l'alcool – constituerait un signal prix *optimal* à destination des consommateurs, c'est-à-dire permettant d'égaliser les recettes fiscales au coût de traitement des pathologies associées à l'alcool [33]. Une politique de hausse des prix de l'alcool ne doit cependant pas être source d'inégalités en direction des individus les plus précaires, ni créer un impôt régressif.

Enfin, nous avons vu que la charge fiscale pour 10 grammes d'alcool pur présente un rapport de 1 à 62 entre les vins tranquilles et les spiritueux. Or, les dommages causés par l'alcool proviennent non pas du type d'alcool mais de la quantité d'alcool pur consommée, conjuguée au mode de consommation. Karsenty et Benamram énoncent alors que « *toutes les boissons alcooliques devraient être taxées selon la quantité d'alcool qu'elles contiennent, l'éthanol étant la seule substance créant des externalités négatives dont la collectivité doit être remboursée* » [34].

Aussi, l'Université de Sheffield a cherché à modéliser l'impact de l'instauration d'un prix minimum du gramme d'alcool sur différentes conséquences économiques et sanitaires de l'abus d'alcool : vies sauvées, admissions hospitalières évitées, réduction du chômage, etc. Pour l'Angleterre, les résultats indiquent que fixer un prix-plancher du gramme d'alcool à 5 pence permet de diminuer la consommation moyenne d'alcool de 6,9 % – les buveurs excessifs réduisant davantage leur consommation que les buveurs modérés –, et d'économiser 6,2 milliards de livres sur 10 ans [35]. Pour la province canadienne de Colombie Britannique, une hausse de 10 % du prix minimum d'un verre standard d'alcool (soit 17,05 ml d'éthanol) pour l'ensemble des boissons alcoolisées permet de réduire la consommation globale d'alcool de 3,4 % [36]. De plus, l'instauration d'une politique de prix minimum a pour effet de diminuer la consommation et les dépenses d'alcool des groupes socio-économiques les plus défavorisés ; les groupes socio-économiques les plus favorisés réduisent quant à eux leur consommation mais augmentent leurs dépenses d'alcool [37]. Enfin, pour les États-Unis, Kerr et

[10] Notons qu'un verre standard pour les États-Unis correspond à 13,7 grammes d'alcool pur.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

Greenfield signalent que les 10 % des buveurs les plus importants dépensent 0,79 $ par verre standard contre 4,75 $ par verre standard pour les 50 % des plus faibles buveurs [38]. Ainsi, l'instauration d'un prix minimum du gramme d'alcool permet, contrairement à des hausses de taxes ciblant une seule boisson alcoolisée, d'éviter des phénomènes de substitution en faveur d'une boisson alcoolique moins onéreuse. Néanmoins, une politique de taxation portant sur le segment le moins cher du marché des boissons alcooliques pourrait également permettre de lutter contre la consommation excessive d'alcool [39].

Conclusion

En France, les politiques publiques de lutte contre la consommation nocive d'alcool, d'abord concentrées sur la répression de l'ivresse, s'attachent à protéger les populations les plus vulnérables à l'alcool et à lutter contre la consommation d'alcool au volant et en milieu professionnel. En dépit de ces politiques, le nombre de décès attribuables à l'alcool était encore estimé à 49 000 en 2009, dont la majorité provient d'une consommation nocive d'alcool sur le long terme (cancer, cirrhose, etc.) [8]. Malgré la prédominance des morts imputables à une consommation de long terme, les politiques publiques de lutte contre les méfaits de l'alcool visent principalement à limiter les risques de court terme résultant d'une consommation importante d'alcool à un moment donné (accident de la route, violences, etc.). Des politiques publiques volontaristes visant à infléchir la mortalité liée à la consommation nocive d'alcool sont alors nécessaires : taxation des boissons alcooliques selon la quantité d'alcool contenue, prix-plancher du gramme d'alcool pur, hausse des taxes sur les boissons alcooliques, etc.

Aucun conflit d'intérêt déclaré

Remerciements :
L'auteur tient à remercier le rapporteur de la revue auquel a été soumis l'article pour l'ensemble de ses commentaires, remarques et précisions qui ont nettement contribué à améliorer la qualité de l'article.

Références

1. Beck F, Richard JB, Guignard R, Le Nézet O, Spilka S. Les niveaux d'usage des drogues en France en 2014. Tendance. 2015;(99):1-8.
2. OCDE. Panorama de la santé 2015 : Les indicateurs de l'OCDE. Paris : Éditions OCDE ; 2015. 200 p.
3. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Consommation des ménages. http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=natfps05116 (consulté le 4 février 2016).
4. Commission des comptes de la Sécurité sociale. Les comptes de la Sécurité sociale : résultats 2010, prévisions 2011. Paris : Commission des comptes de la Sécurité sociale (Fr) ; 2011. 452 p.
5. Maestracci N. Les drogues. Paris : Presses universitaires de France ; 2005. 128 p.
6. César G, Cugnenc PH, Martin PA, Poignant S, Suguenot A. Le livre blanc de la viticulture française – Le rôle et la place du vin dans la société. Rapport au Premier Ministre (Fr) ; 2004. 82 p.
7. Lachenmeier DW, Rehm J. Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Scientific reports. 2015;5(8126):1-7.
8. Guérin S, Laplanche A, Dunant A, Hill C. Alcohol-attributable mortality in France. The European Journal of Public Health. 2013;23(4):588-93.
9. Kopp P. Le coût social des drogues en France. Paris : OFDT; 2015. 74 p.
10. Canarelli T, Cadet-Tairou A, Palle C. Indicateurs de la morbidité et de la mortalité liés à l'alcool en France. BEH. 2006;(34-35):252-5.
11. Perrine AL, Develay AE. Recours aux urgences pour intoxication éthylique aiguë en France en 2011. L'apport du réseau Oscour®. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2013;(16-17-18):195-8.
12. Inserm. Alcool : Dommages sociaux, abus et dépendance. Expertise collective. Paris : Les éditions Inserm ; 2003. 536 p.
13. Palle C. Synthèse de la revue de littérature sur les consommations de substances psychoactives en milieu professionnel. Saint-Denis : OFDT. 2015; note 2015-05. 12 p.
14. Amalric F. Analyse économique des coûts du cancer en France. Impact sur la qualité de vie, prévention, dépistage, soins, recherche. Boulogne-Billancourt : Institut national du cancer (INCa);2007. 140 p.
15. Bernard H. Alcoolisme et antialcoolisme en France au XIXe siècle : autour de Magnus Huss. Histoire, Économie et Société. 1984; 3(3-4):609-28.
16. Lamy L. Étude de statistique clinique de 134 cas de cancer de l'œsophage et du cardia : observations recueillies dans le service de M. le Dr A. Mathieu (hôpital St-Antoine). Thèse de doctorat; 1910.
17. Doll R, Peto R, Hall E, Wheatley K, Gray R. Mortality in relation to consumption of alcohol: 13 years' observation on male British doctors. BMJ. 1994;309(6959):911-918.
18. Inpes. Boire un peu trop d'alcool tous les jours… c'est mettre sa vie en danger. Dossier de presse du 10 mars 2011. 2011.
19. Caballero F, Bisiou Y. Droit de la drogue. 2e éd. Paris : Dalloz ; 2000. 827 p.
20. Lecoutre M. Ivresse et ivrognerie dans la France moderne. Rennes (France) : Presses universitaires de Rennes, Presses universitaires François-Rabelais de Tours ; 2011. 400 p.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.

21. Bachmann C, Coppel A. Le dragon domestique. Paris : Albin Michel ; 1989. 564 p.
22. Marshall EJ. Adolescent alcohol use: risks and consequences. Alcohol and alcoholism. 2014;49(2):160-4.
23. Lenglet R, Topus B. Santé publique et pouvoir politique face aux lobbies industriels. Les Tribunes de la Santé. 2003;1(1):47-58.
24. Bourdillon F. Les lobbies agroalimentaires contre la santé publique. Santé Publique. 2005;17(4):515-6.
25. Ben Lakhdar C. Chiffres clés de l'économie de l'alcool en France. Actualité et dossier en santé publique. 2015;(90):22.
26. Wagenaar AC, Salois MJ, Komro KA. Effects of beverage alcohol price and tax levels on drinking: a meta-analysis of 1003 estimates from 112 studies. Addiction. 2009;104(2):179-90.
27. Elder RW, Lawrence B, Ferguson A, Naimi TS, Brewer RD, Chattopadhyay SK, *et al.* The effectiveness of tax policy interventions for reducing excessive alcohol consumption and related harms. Am J Prev Med. 2010;38(2):217-29.
28. Cobiac L, Vos T, Doran C, Wallace A. Cost-effectiveness of intervention to prevent alcohol-related disease and injury in Australia. Addiction. 2009;104(10):1646-55.
29. Daley JI, Stahre MA, Chaloupka FJ, Naimi TS. The impact of a 25-cent-per-drink alcohol tax increase. Am J Prev Med. 2012;42(4):382-9.
30. Wagenaar AC, Tobler AL, Komro KA. Effects of alcohol tax and price policies on morbidity and mortality: a systematic review. American Journal of Public Health. 2010;100(11):2270-8.
31. Grossman M. The economic analysis of addictive behavior. *In:* Hilton ME, Bloss G, Eds. Economics and the Prevention of Alcohol Related Problems. Rockville (États-Unis): National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism; 1993. 241 p.
32. Chisholm D, Rehm J, Van Ommeren M, Monteiro M. Reducing the global burden of hazardous alcohol use: a comparative cost-effectiveness analysis. Journal of Studies on Alcohol. 2004;65(6):782-93.
33. Dufernez AS, Lapegue V. Fiscalité optimale des produits à risque. Faire prendre conscience aux consommateurs les coûts sociaux associés à leurs décisions de consommation. Les Cahiers de la DG Trésor. 2013;(2013-07):1-40.
34. Karsenty S, Benamram S. Alcool : quelle politique des prix ? Actualité et dossier en santé publique. 2015;(90):28-9.
35. Purshouse RC, Meier PS, Brennan A, Taylor KB, Rafia R. Estimated effect of alcohol pricing policies on health and health economic outcomes in England: an epidemiological model. The Lancet. 2010;375(9723):1355-64.
36. Stockwell T, Auld MC, Zhao J, Martin G. Does minimum pricing reduce alcohol consumption? The experience of a Canadian province. Addiction. 2012;107(5):912-20.
37. Holmes J, Meng Y, Meier PS, Brennan A, Angus C, Campbell-Burton A, *et al.* Effects of minimum unit pricing for alcohol on different income and socioeconomic groups: a modelling study. The Lancet. 2014;383(9929):1655-64.
38. Kerr WC, Greenfield TK. Distribution of alcohol consumption and expenditures and the impact of improved measurement on coverage of alcohol sales in the 2000 National Alcohol Survey. Alcoholism: Clinical and Experimental Research. 2007;31(10):1714-22.
39. OCDE. Lutter contre la consommation nocive d'alcool : Politiques économiques et de santé publique. Paris : Éditions OCDE;2015. 265 p.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Université de Paris 7 - - 81.194.22.198 - 08/11/2016 14h58. © S.F.S.P.